

2024-2025

2^{ème} années Master

Apprentissage en milieu clinique

O.R.L.

Cahier de l'étudiant-e



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTÉ DE MÉDECINE

APPRENTISSAGE EN MILIEU CLINIQUE (AMC)

O.R.L

TABLE DES MATIERES

INFORMATIONS GENERALES.....	1
OBJECTIFS GENERAUX	3
Otologie et otoneurologie	4
Rhinologie	5
Laryngologie et chirurgie cervico-faciale	6
Glandes salivaires	7
DISCIPLINES ETUDIEES.....	9
ACTIVITES	11
REFERENCES	13
PROBLEMES OTOLOGIE – OTONEUROLOGIE	15
Problème n°1: J'ai mal à l'oreille.....	17
Problème n°2: Ça tourne	21
PROBLEMES RHINOLOGIE – OLFACTOLOGIE	23
Problème n°3: J'ai l'œil qui gonfle	25
Problème n°4: Je saigne du nez.....	29
PROBLEMES CHIRURGIE CERVICO-FACIALE ET LARYNGOLOGIE	31
Problème n°5: Une boule dans le cou	33
Problème n°6: J'ai la voix changée.....	37
PROBLEME GLANDES SALIVAIRES	39
Problème n°7: Je gonfle sous le menton	41
PROBLEME ORL GENERAL.....	43
Problème n°8: J'ai mal à la gorge.....	45
PROBLEME ORL PEDIATRIQUE	47
Problème n°9: Mon enfant n'entend pas bien.....	49
COURS / SEMINAIRES	51
Cours d'Anatomie	51
Cours de Radiologie	51

Directives de Présence et Participation aux Activités

Conformément au règlement facultaire, la présence requise ne se base pas que sur le GPS mais sur l'ensemble des activités théoriques et pratiques. Ainsi, le stage AMC ne sera validé que pour les étudiant-es ayant réalisé de manière adéquate la totalité des activités du programme. La semaine d'examens oraux n'est pas une exception, ni une semaine de révision sans activité obligatoire.

Activités Structurées (tutoriaux, séminaires, etc.)

1. **Présence et Ponctualité** : La présence et la ponctualité lors des activités organisées sont requises.
2. **Implication et Participation Active** : Les étudiant-es s'impliquent activement durant les activités.
3. **Préparation Préliminaire** : Certaines activités nécessitent une préparation préalable (lectures, préparation de cas, etc.).
4. **Auto-apprentissage** : Les étudiant-es réalisent les objectifs d'enseignement reliés à chaque activité.
5. **Évaluation Constructive** : Les étudiant-es sont encouragés à évaluer les activités et les enseignants pour signaler les améliorations possibles.

Activités dans les Unités de Soins

1. **Présence et Ponctualité** : La présence aux activités de l'unité (visites, colloques, etc.) est obligatoire.
2. **Implication Personnelle** : Les étudiant-es s'impliquent personnellement dans les activités cliniques, qu'elles soient directes ou indirectes.
3. **Attitude Collégiale** : Une attitude collégiale envers les collègues, le corps infirmier et autres collaborateurs est attendue.
4. **Attitude Professionnelle** : Les étudiant-es adoptent une attitude professionnelle envers les collègues, patients et leur famille comme mentionné dans PROFILES ainsi que dans la charte de professionnalisme.

Directives Générales

La participation à tous les cours et séminaires est obligatoire, de même que la présence quotidienne durant les stages cliniques. En cas d'absence dûment justifiée (maladie, accident, deuil), il est impératif d'avertir le plus rapidement possible le secrétariat et les responsables de stage. Un justificatif pourra être demandé selon le motif de l'absence. Le non-respect de ces directives peut entraîner la non-validation du stage.

INFORMATIONS GENERALES

PERSONNES CONCERNEES

GROUPE DE TRAVAIL DE L'AMC

Nom	Dpt / Unité / Cabinet médical	Téléphone
<u>Responsable</u>		
Prof Basile Landis	Service d'Oto-rhino-laryngologie et Chirurgie cervico-faciale	(37) 28 233
<u>Co-Responsable</u>		
PD Dr Nils Guinand	Service d'Oto-rhino-laryngologie et Chirurgie cervico-faciale	(37) 28 233

Tuteurs de l'AMC

Nom	Service / Dpt / Unité / Cabinet	Téléphone
Prof. P. Senn	Service d'Oto-rhino-laryngologie et Chirurgie cervico-faciale	(37) 28 233
Prof B. Landis	Idem	(37) 28 234
PD Dr I. Leuchter	Idem	
PD Dr Y. Monnier	Idem	(37) 28 285
Dr N. Dulguerov	Idem	
Dre H. Cao Van	Idem	
PD Dr N. Guinand	Idem	
PD Dre ing. A, Perez-Fornos	Idem	
Prof. M. Becker	Service de Radiologie, HUG	
Prof. B. Stimec	Anatomie clinique, Université de Genève	
Dr C. Cuffel	Chemin de Beau-Soleil 12, 1206 Genève	022 347 13 96
Dr D. Quinodoz	Prom. Des Artisans 24, 1217 Meyrin	022 719.74.74
Prof. F. Marchal	Cours de Rive 16, 1204 Genève	022 735.72.40
Dr P. Bang	Rue Liotard 58, 1203 Genève	(37) 28 233

OBJECTIFS GENERAUX

Au terme de l'AMC, l'étudiant-e devrait avoir acquis les **compétences cliniques et les gestes techniques** spécifiques suivants:

- Effectuer une anamnèse ORL ;
- Identifier les pathologies fréquentes en ORL ;
- Planifier les investigations complémentaires spécifiques à la spécialité ;
- Etablir un plan de traitement en connaissance des interventions chirurgicales existantes.

Examen ORL, comprenant:

- Examen de l'oreille avec un otoscope ;
- Acoumétrie (épreuves de Weber et Rinne ; tests de perception de la voix chuchotée, parlée ou criée) ;
- Examen vestibulaire clinique (recherche d'un nystagmus sous lunette de Frenzel, Head impulse test, Examen calorique) ;
- Palpation de la face et du nez ;
- Test de la sensibilité (V) et motricité (VII) de la face ; Examen des nerfs crâniens
- Rhinoscopie antérieure et postérieure (speculum, miroir, endoscopie) ;
- Test de la perméabilité nasale (Cottle, rhinohygrométrie) ;
- Test de l'olfaction et de la gustation
- Examen de la cavité buccale (palpation incluse) et de l'oropharynx ;
- Examen des glandes salivaires et des canaux salivaires
- Examen du pharyngo-larynx au miroir ;
- Palpation des ganglions et structures du cou.

OTOLOGIE ET OTONEUROLOGIE

Problèmes cliniques	Entités nosologiques	Interventions chirurgicales
Otalgie	Otite externe Myringite bulleuse Otite moyenne aiguë Mastoïdite Zona otique Otalgie réflexe	Paracentèse Mastoïdectomie
Ecoulement d'oreille	Otite moyenne chronique: - inactive - cholésteatomateuse	Tympanoplastie Evidement pétro-mastoïdien
Traumatisme	Perforation tympanique Fracture de l'os temporal Othématome	
Hypoacousie	Bouchon de cérumen Otite séro-muqueuse Otosclérose Presbyacousie Traumatismes acoustiques Surdité brusque Surdité congénitale	Drain transtympanique Stapédotomie Appareillage acoustique Implant cochléaire
Vertiges	Maladie de Menière Vertige paroxystique de position Déficit vestibulaire brusque (neuronite vestibulaire) Déficit vestibulaire bilatéral Presbyvestibulopathie Migraine vestibulaire PPPD Déhiscence du canal semi-circulaire supérieur Paroxysmie vestibulaire Schwannome vestibulaire	Labyrinthectomie chirurgicale et chimique Neurectomie vestibulaire Colmatage du canal semi-circulaire supérieur Implant vestibulaire Exérèse chirurgicale 'Radiochirurgie'
Paralysie faciale	Paralysie idiopathique (Bell) Zona otique	

RHINOLOGIE

Problèmes cliniques	Entités nosologiques	Interventions chirurgicales
Obstruction nasale	Rhinosinusite aiguë Rhinosinusite chronique +/- polypose nasale Hypertrophie des adénoïdes. Allergies Malformation anatomique septale et/ou turbinale Tumeur bénigne ou maligne Atrésie choanale	Chirurgie rhinosinusienne sous contrôle endoscopique. Adénoïdectomie Septoplastie, turbinoplastie
Ecoulement nasal	Rhinosinusite aiguë ou chronique, allergie, dysfonction du système nerveux autonome	Méatotomie moyenne Ethmoïdectomie
Epistaxis	Epsistaxis antérieure supérieure postérieure Traumatisme nasal, facial Tumeurs du massif facial	Tamponnement Cautérisation Embolisation, Ligature des artères ethmoïdales Reposition nasale, rhinoplastie
Hyposmie, anosmie Douleurs faciales	Rhinosinusite aiguë ou chronique	Tests olfactifs/gustatifs

LARYNGOLOGIE ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

Problèmes cliniques	Entités nosologiques	Interventions chirurgicales
Odynodysphagie	Amygdalite Abscess péri-amygdaire Pharyngite Corps étranger pharyngé Cancers du pharynx	Tonsillectomie Panendoscopie
Dysphagie	Troubles de la déglutition Diverticule de Zenker Reflux pharyngo-laryngé	
Dysphonie	Laryngite aiguë et chronique Lésions bénignes des cordes vocales (nodules, polype, œdème de Reinke, kystes, ...) Cancers du larynx Paralysie cordale	Microlaryngoscopie en suspension Laryngectomie partielle ou totale Laryngoplastie
Dyspnée	Epiglottite Paralysie cordale Traumatismes du larynx Papillomatose laryngée Sténose sous-glottique Laryngomalacie Pathologies trachéales	Coniotomie, Trachéotomie Corpectomie, Aryténoïdectomie Résection cricotrachéale
Ronflement	Apnée du sommeil	
Stertor	Hypertrophie adénotonsillaire	Adénoïdectomie Tonsillectomie
Lésions buccales	Inflammations et infections orales Cancers de la cavité buccale	 Pelviglossectomie
Masse cervicale	Kystes cervicaux Abscess cervicaux Adénites chroniques Adénopathies malignes	Exérèse Cervicotomie Adénectomie Evidement ganglionnaire cervical

GLANDES SALIVAIRES

Tuméfaction des
glandes salivaires

Sialadénite et sialolithiase

Sialendoscopie

Oreillons
Tumeurs malignes et
bénignes des glandes
salivaires

Sous-maxillectomie
Parotidectomie

Xérostomie

Sialadénite
Maladie de Sjögren

Sialométrie

DISCIPLINES ETUDIEES

- ANATOMIE

- ORL

- RADIOLOGIE

ACTIVITES

ORGANISATION DE L'AMC

Lors de leur passage en ORL, pendant les deux semaines les étudiant-es auront une présentation théorique de la matière (Otoneurologie, Otologie, Rhinologie, Laryngologie et Chirurgie cervico-faciale. Ils seront aussi répartis en deux groupes pour étudier 8 problèmes cliniques couvrant l'ensemble de la spécialité. Pour chaque problème, les objectifs d'apprentissage sont remis au début de l'AMC. Ils sont discutés dans un tutorial à la fin de l'auto-apprentissage. Beaucoup d'importance est attaché aux capacités de correctement examiner le patient-e. En petit groupes (quart de demi-volée) les étudiant-es apprendront sous supervision l'examen clinique ORL.

GUIDE DU TUTEUR

Le guide du tuteur a été formulé sous forme de questions-réponses. Il sert de base à l'acquisition des connaissances mais ne représente pas forcément la forme du tutorial.

DISCIPLINES TRANSVERSALES INTEGREES DANS L'AMC

Anatomie (Prof. B. Stimec)

L'anatomie complexe de la tête et du cou est rappelée au cours des deux semaines.

Radiologie (Prof. M. Becker)

Un séminaire de 2 heures a lieu, pour aborder l'aspect radiologique des affections ORL les plus fréquentes. Des images radiologiques avec résumés seront mises à disposition pour l'auto-apprentissage.

REFERENCES

REFERENCES RECOMMANDEES

- Legent F, et al. **ORL, pathologie cervico-faciale**. 6ème édition. Paris Masson, 2003.
- R. Probst, G. Grevers, H. Iro. **Basic Otorhinolaryngology: a step by step learning guide** 2nd ed. Stuttgart : Thieme, 2018. WV 140 4 et 2
- JPh Guyot. **Otologie et otoneurologie pour le praticien et l'étudiant**. Editions Médecine et Hygiène, Genève, janvier 2005.
- JPh Guyot. **Les vertiges de l'oreille pour les étudiants et médecins que ça intrigue ou ça amuse**. A obtenir au secrétariat administratif de service ORL.
- A. Lalwani : Current diagnosis and treatment in Otolaryngology. 2nd ed. New-York, McGrawHill, 2007.
- D. Brasnu: Traité d'ORL, Médecine-Science, Flammarion, 1ere edition, Paris, 2008
- M. Anniko : Otrrhinolaryngology Head & Neck Surgery, Springer, 2010
- N.J. Roland, R.DR. Mc Rae, A.W. McCombe. Key topics in otolaryngology. 3rd ed. Stuttgart : Thieme, 2019. WV 39 7 ed 2
- JW. Jr Williams et al. **Does this patient have sinusitis?** JAMA, 1993, 270(10) :1242-1246.
- Lardon N, Dulguerov P, Becker M, Allal AS, Kurt AM, Lehmann W: Groupes ganglionnaires et évidements cervicaux: nouvelle nomenclature. *Méd & Hyg* 57:1989-1993,1999.
- Dulguerov P : Mode d'extension des cancers du larynx. *Méd & Hyg* 53:2217-2222,1995
- Marchal F, Dulguerov P: Sialolithiasis management: the state of the art. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 129:951-956, 2003.
- **Bárány Society initiative for the establishment of the International Classification of Vestibular Disorders (ICVD)** <http://www.jvr-web.org/ICVD.html>
- **SOREL: Swiss ORL E-learning:** <http://sorel-ori.ch>

PROBLEMES

OTOLOGIE – OTONEUROLOGIE

PROBLEME N°1: J'AI MAL A L'OREILLE

ENONCE INITIAL : ETAPE 1/4

Monsieur Oto, un patient de 40 ans, en bonne santé habituelle consulte en raison d'une douleur et d'un écoulement de l'oreille droite évoluant depuis quelques jours.

Il signale que cette oreille coule régulièrement, depuis de nombreuses années.

Il se plaint également d'une mauvaise audition des 2 côtés, de longue date.

Quel est le diagnostic différentiel de l'épisode actuel ?

ENONCE : ETAPE 2/4

A l'examen sous microscope, le conduit auditif externe droit est rempli de sécrétions jaunes-verdâtres, nauséabondes (odeur de fromage). Après aspiration, les téguments du conduit apparaissent légèrement tuméfiés et érythémateux. Il y a une perforation tympanique postéro-supérieure, marginale. Elle est comblée de tissu blanc nacré.

A gauche, le tympan présente une perforation centrale, sèche, au travers de laquelle la chaîne ossiculaire est visible.

Le Weber est latéralisé à droite, le Rinne est négatif des deux côtés. Seule la voix haute est comprise des deux côtés, un peu mieux à gauche qu'à droite.

Quel est le diagnostic différentiel, maintenant ?

Quels examens complémentaires proposez-vous ?

ENONCE : ETAPE 3/4

Le bilan est maintenant terminé.

Quels sont les diagnostics des affections de l'oreille droite et gauche ?

Quel(s) traitement(s) proposez-vous ?

ENONCE : ETAPE 4/4

Vous revoyez le patient six mois après l'intervention chirurgicale de l'oreille droite. Elle s'est déroulée sans complication. L'audiogramme de contrôle montre un bon gain auditif.

Le patient vous demande si une intervention est nécessaire au niveau de l'oreille gauche.

Que proposez-vous pour l'oreille gauche ?

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

- **Problème clinique** - Otalgie, hypoacousie.
- **Diagnostic** - Otite moyenne chronique avec cholestéatome.
- **Entités nosologiques** - Infection chronique et aiguë de l'oreille externe et moyenne.
- **Aspect(s) privilégié(s)** - Diagnostic des infections chroniques de l'oreille moyenne.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
<i>Après avoir étudié ce problème, les étudiants devraient:</i>	
- Connaître l'anatomie de l'oreille externe et moyenne.	ANATOMIE
- Savoir différencier un déficit auditif de transmission et de perception. Acoumétrie et audiogramme.	ORL
- Faire le diagnostic différentiel entre otite moyenne aiguë et externe.	ORL
- Connaître le traitement initial d'une otite externe et moyenne.	ORL
- Connaître les problèmes relatifs à une otite externe ou moyenne aiguës et ses complications.	ORL
- Connaître les problèmes relatifs à une otite moyenne chronique sans ou avec cholestéatome, et ses complications.	ORL
- Connaître les indications opératoires et avoir quelques notions des interventions chirurgicales possibles.	ORL

PROBLEME N°2: ÇA TOURNE

ENONCE INITIAL : ETAPE 1/3

Madame Chantal B., 45 ans, est en bonne santé habituelle. Elle consulte en urgence en raison d'un vertige rotatoire d'installation subite il y a quelques heures. Le vertige est accompagné d'importantes nausées et vomissements. La patiente est très inquiète car sa mère a fait, récemment, une 'attaque' qui a commencé par des vertiges. Elle a peur de souffrir du même problème.

Peut-il s'agir d'un accident vasculaire cérébral ?

ENONCE : ETAPE 2/3

A l'examen, il y a un nystagmus spontané horizontal battant vers la droite.

Le Head Impulse Test (HIT) est pathologique à gauche. Il n'y a pas de changement de direction du nystagmus en fonction de la direction du regard (pas de gaze nystagmus). Il n'y a pas de « skew deviation ».

Par ailleurs, à l'épreuve calorique à 24°, la stimulation de l'oreille droite induit un nystagmus battant vers la gauche. La stimulation de l'oreille gauche ne modifie pas le nystagmus spontané (battant vers la droite). Le reste de l'examen vestibulaire et l'examen des nerfs crâniens sont normaux.

On note encore une déviation vers la gauche à l'Unterberger et au Romberg.

Que concluez-vous de l'examen vestibulaire clinique ? Quel est votre diagnostic ?

ENONCE : ETAPE 3/3

Pour l'exercice, admettons que lorsque vous revoyez la patiente 1 heure après l'examen, elle va nettement mieux. Elle signale que l'audition était altérée à gauche durant la crise de vertige, et qu'elle est redevenue normale peu après.

A l'examen, le nystagmus spontané a disparu. Le HIT est normal. Il n'y a plus de déviation à l'Unterberger, ni au Romberg.

Elle vous demande si de tels épisodes risquent de se reproduire.

Quel serait votre diagnostic ? et que lui répondriez-vous ?

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

- **Problème clinique** - Crise de vertige brusque (syndrome vestibulaire aigu)
-hypoacousie.
- **Diagnostic** - Déficit vestibulaire brusque
-Maladie de Menière.
- **Entités nosologiques** - Vertiges d'origine périphérique ;
- Affections de l'oreille interne.
- **Aspect(s) privilégié(s)** - Diagnostic différentiel des vertiges.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
<i>Après avoir étudié ce problème, les étudiants devraient :</i>	
- Connaître l'anatomie de l'oreille interne et du vestibule.	ORL, ANATOMIE
- Connaître les principales voies vestibulaires centrales.	ORL
- Connaître les principales causes de vertige, périphériques et centrales.	ORL, NEUROLOGIE
- Identifier une maladie de Menière, un déficit vestibulaire brusque (synonymes : neuronite vestibulaire et vestibulopathie unilatérale aiguë), un déficit vestibulaire bilatéral, une labyrinthite, un vertige paroxystique bénin de position, un schwannome vestibulaire (synonyme : neurinome de l'acoustique), un paroxysme vestibulaire, une migraine vestibulaire, un PPPD (Persistent, postural, perceptual dizziness).	ORL
- Appliquer le « HINTS » (rechercher un nystagmus spontané (utilisation des lunettes de Frenzel), pratiquer le « Head Impulse Test » (HIT), rechercher un « gaze » nystagmus et une « skew deviation »). Rechercher un nystagmus provoqué (« Headshaking », changement de position (Hallpike, « Supine Head Roll Test »), calorique). Effectuer un test de Romberg, Unterberger, de coordination (doigt-nez, diadococinésie), Connaître le neurinome de l'acoustique.	ORL
- Tester la fonction du nerf facial.	ORL

PROBLEMES

RHINOLOGIE – OLFACTOLOGIE

PROBLEME N°3: J'AI L'ŒIL QUI GONFLE

(CONTEXTE DES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES – INFECTIEUSES AIGÜES ET CHRONIQUES)

ENONCE INITIAL: ETAPE 1/3

Monsieur Max, un patient de 25 ans, consulte en raison d'un œdème et d'un érythème péri-orbitaire droit apparu le matin au réveil. Il revient d'un séjour de vacances de sports d'hiver. Depuis 5 jours, il se plaint d'une obstruction nasale bilatérale presque totale avec anosmie et, depuis 3 jours, d'un écoulement et de mouchages épais et colorés à prédominance droite. Il rapporte une sensation de pression douloureuse de l'hémiface droite, aggravée lorsqu'il penche la tête en avant.

Il a déjà souffert de symptômes identiques, mais jamais d'un œdème périorbitaire.

Il décrit également une obstruction nasale bilatérale chronique depuis environ 5 ans, plus marquée à gauche qu'à droite, avec des mouchages productifs, une sensation d'écoulement postérieur et des douleurs fronto-temporales intermittentes. Il se plaint d'une toux non productive à prédominance matinale, d'une diminution de ses sensations olfactives, d'une fatigue chronique et d'une baisse significative de sa qualité de vie familiale, sociale et professionnelle. Il prend 2 à 3 cures d'antibiotiques par année.

Il est en bonne santé, ne fume pas.

- *Quelle est l'origine des symptômes présents depuis 5 ans et de l'œdème périorbitaire actuel?*

ENONCE: ETAPE 2/3

L'examen montre un œdème et un érythème des paupières supérieure et inférieure droites, fermant complètement l'œil. La vision et les mouvements oculaires sont conservés lorsqu'on écarte les paupières avec les doigts.

A l'examen endoscopique des fosses nasales, il existe un très important œdème et érythème des muqueuses septales et turbinales. A droite, des sécrétions purulentes sont visibles au niveau du vestibule, du plancher de la fosse nasale et du méat moyen. La cloison nasale présente une déformation à convexité gauche empêchant la visualisation de la partie moyenne et postérieure de la fosse nasale gauche.

- *Quel(s) examen(s) demandez-vous ?*
- *Quel(s) traitement(s) proposez-vous ?*

ENONCE: ETAPE 3/3

Vous revoyez le patient 3 semaines après le début du traitement.

A l'examen, il n'y a plus d'écoulement purulent visible au niveau du méat moyen droit. En plus de la déviation du septum nasal vers la gauche, vous observez une hypertrophie des cornets moyens et inférieurs droits, avec une muqueuse oedématisée et érythémateuse. Il y a une asymétrie au miroir de Glatzel en défaveur de la gauche. Sa capacité d'identification olfactive est diminuée.

Le patient vous demande s'il y a moyen d'éviter les rhinosinusites nécessitant un traitement antibiotique et s'il est possible d'améliorer sa respiration nasale, ses écoulements postérieurs, ses céphalées et son olfaction.

- *Que lui répondez-vous ?*

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

Problème clinique	- Œdème et érythème périorbitaire avec obstruction nasale, rhinorrhée mucopurulente et douleur faciale.
Diagnostic	- Rhinosinusite chronique en poussée aiguë.
Entités nosologiques	- Affection chronique et aiguë des cavités rhinosinusiennes. Etiologie des inflammations et des infections rhinosinusiennes.
Aspect (s) privilégié(s)	- diagnostic différentiel des inflammations rhinosinusiennes.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
<i>Après avoir étudié ce problème, les étudiants devraient :</i>	
- Connaître l'anatomie des cavités rhinosinusiennes	ORL, ANATOMIE
- Connaître les principales causes d'inflammations aiguës et chroniques des cavités rhinosinusiennes, leurs complications locorégionales et leurs comorbidités (atteinte orbitaire et endocraniennes, asthme, toux, fatigue chronique, atteinte de la qualité de vie)	ORL,
- Identifier une rhinosinusite aiguë et chronique, une hyperréactivité spécifique (allergie) ou non spécifique, les agents pathogènes (virus, bactéries, éléments fongiques) impliqués dans les infections rhinosinusiennes, les malformations anatomiques endonasales, une tumeur bénigne ou maligne des cavités rhinosinusiennes	ORL ALLERGOLOGIE
- Evaluer la perméabilité nasale, faire une rhinoscopie antérieure, observer une rhinorrhée antérieure et postérieure (oropharynx), palpation des points sinusiers de la face, évaluer la sensibilité (V), évaluer la fonction olfactive et l'acuité visuelle. Connaître les origines périphériques et centrales des troubles de la fonction olfactive.	ORL
- Effectuer les examens paracliniques (prélèvement bactériologique endonasal, CT scan du massif facial).	ORL
- Appliquer un traitement médical adéquat.	
- Connaître les interventions chirurgicales possibles dans le cadre d'une rhino-sinusite.	

PROBLEME N°4: JE SAIGNE DU NEZ

ENONCE INITIAL: ETAPE 1/3

Monsieur Narina, un patient de 45 ans, consulte en urgence en raison d'épistaxis droites récidivantes, depuis quelques semaines. D'habitude, le saignement se tarissait spontanément après quelques minutes, mais cette fois, il persiste.

- *Qu'elles sont les causes et les sites les plus fréquents d'épistaxis ?*

ENONCE: ETAPE 2/3

La mise en place d'une mèche de tétracaïne et adrénaline dans la fosse nasale droite a permis de tarir le saignement. Il est alors possible d'examiner la fosse nasale. A droite, la tache vasculaire est sans particularité mais il existe une lésion polypoïde jaunâtre au niveau du méat moyen. A gauche, il y a une importante déviation septale à convexité gauche qui empêche un examen complet.

- *Quel est le diagnostic différentiel de la lésion, peut-être unilatérale, droite ?*

ENONCE: ETAPE 3/3

Après une anesthésie locale, il est possible de pousser la cloison nasale médialement et d'examiner la fosse nasale gauche. Au niveau du méat moyen, on note également la présence d'une lésion polypoïde de couleur jaunâtre.

Quel est le diagnostic différentiel, maintenant ?

Quels examens complémentaires proposez-vous ?

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

- **Problème clinique** - Epistaxis.
- **Diagnostic** - Epistaxis secondaire à une inflammation aiguë ou chronique, une tumeur bénigne (polype inflammatoire) ou maligne des cavités rhinosinusiennes.
- **Entités nosologiques** - Epistaxis d'origine inflammatoire aiguë ou chronique, tumorale bénigne ou maligne, post traumatique, secondaire à une maladie systémique
- **Aspect(s) privilégié(s)** - Diagnostic différentiel d'une tumeur endonasale.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
<i>Après avoir étudié ce problème, les étudiants devraient être capables de connaître:</i>	
- L'anatomie de la vascularisation rhinosinusienne, les différents types d'épistaxis (antérieure, postérieure ou supérieures) et leurs traitements.	ANATOMIE ORL
- Les inflammations aiguës ou chroniques, les tumeurs bénignes (papillome, basaliome, polype inflammatoire ou fibroangiomateux) ou malignes (carcinome épidermoïde, adénocarcinome, mélanome, neuroesthésioblastome, lymphome) des cavités rhinosinusiennes.	ORL
- Les maladies systémiques pouvant être à l'origine d'une épistaxis (vasculite, sarcoïdose ...)	ORL MEDECINE INTERNE

PROBLEMES

CHIRURGIE CERVICO-FACIALE ET LARYNGOLOGIE

PROBLEME N°5: UNE BOULE DANS LE COU

ENONCE INITIAL: ETAPE 1/3

Monsieur Cervico, d'origine africaine, est âgé de 40 ans. Il vit en Suisse depuis 20 ans. Il est adressé par son médecin traitant pour une tuméfaction cervicale droite, progressive depuis 1 mois, légèrement douloureuse, sans autre plainte ORL. Un traitement d'ampiciline-clavulanate 625 mg po 3 fois par jour pendant 10 jours n'a pas changé le tableau clinique.

- *Chez l'adulte, quelle est l'origine principale des tuméfactions cervicales ?*
- *Quels éléments anamnestiques sont déterminants pour la suite des investigations ?*

ENONCE : ETAPE 2/3

Monsieur Cervico ne fume pas et ne boit pas d'alcool. Il y a plusieurs années, il avait déjà présenté une tuméfaction cervicale au niveau de la partie moyenne du cou à droite. Elle était apparue dans les suites d'un état grippal et avait guéri après un traitement antibiotique.

L'examen clinique met en évidence une tuméfaction de 3 x 4 cm au niveau jugulaire supérieur droit. Elle est non pulsatile, ferme à élastique, relativement mobile dans tous les plans, légèrement douloureuse. La peau en regard de la tuméfaction est discrètement rouge. Il n'y a pas d'autre masse palpable au niveau du cou. Hormis un mauvais état dentaire, le reste de l'examen des voies aéro-digestives ne montre aucune anomalie. L'examen général est normal. En particulier, il n'y a pas d'hépatosplénomégalie.

- *Quel est le diagnostic différentiel ?*
- *Quels examens proposez-vous ?*

ENONCE : ETAPE 3/3

Le test de Mantoux est négatif, la radiographie du thorax normale. La sérologie pour une toxoplasmose s'est révélée négative, de même qu'un test HIV. Il n'y a pas de chat dans l'entourage du patient. L'examen par un dentiste a exclu un foyer infectieux dentaire.

Une cytoponction a ramené du liquide citrin. L'examen de ce dernier n'a pas montré de cellules suspectes de malignité, ni de bacille BAAR ou d'actinomycètes à l'examen direct.

- *Quel est le diagnostic différentiel, maintenant ?*
- *Si le patient avait fumé un paquet de cigarettes par jour et bu 1/2 litre de vin par jour, auriez-vous proposé une autre démarche diagnostique ?*
- *Quel traitement proposez-vous pour ce patient ?*
- *Quelle opération et comment informez-vous le patient ?*

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

- **Problème clinique** - Tuméfaction cervicale chronique.
- **Diagnostic** - Kyste branchiogène.
- **Entités nosologiques** - Kyste branchiogène, lymphome, tuberculose, métastases d'un carcinome épidermoïde.
- **Aspect(s) privilégié(s)** - Diagnostic différentiel d'une masse cervicale.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
<i>Après avoir étudié ce problème, les étudiants devraient:</i>	
- Connaître l'anatomie du cou	ANATOMIE
- Connaître les tuméfactions cervicales bénignes (kyste thyroïdienne, kyste branchiogène, goitre, adénites virales aiguës, adénites bactériennes suppuratives, adénites tuberculeuses, maladie des griffes de chat, toxoplasmose, adénopathie HIV, lymphangiomes, hémangiomes, paragangliomes) ou malignes (métastases, métastases sans porte d'entrée, lymphome)	ORL
- Connaître le diagnostic différentiel des tuméfactions en fonction de la région cervicale touchée	ORL
- Savoir palper le cou	ORL
- Déterminer les examens complémentaires (Ct-scan, cytoponction, ultrasonographie, panendoscopie)	ORL
- Connaître les lignes générales des traitements des métastases ganglionnaires cervicales.	ORL

PROBLEME N°6: J'AI LA VOIX CHANGEE

Un patient de 52 ans, tabagique à 35 UPA, consulte en raison d'une aggravation d'une dysphonie, depuis 1 mois. A relever qu'à la suite d'une thyroïdectomie totale il y a 15 ans il a présenté une modification importante de la voix, avec récupération incomplète.

Quelle est la nature du problème actuel ?

Comment évaluer la voix ?

Quels sont les symptômes associés à rechercher ?

ENONCE : ETAPE 2/3

- L'examen laryngé montre une immobilité laryngée gauche avec une corde vocale en position paramédiane. La corde vocale droite est bien mobile et présente un bombement muqueux irrégulier dans sa portion postérieure.
-
- *Quels diagnostics peut-on envisager à ce stade ?*
-
- *Comment investiguer une immobilité laryngée ?*
-
- *Des investigations complémentaires sont-elles nécessaires ?*
-
- *Quel est le degré d'urgence ? Pourquoi ?*

ENONCE: ETAPE 3/3

Une microlaryngoscopie en suspension est effectuée et montre une lésion bourgeonnante infiltrant les deux tiers postérieurs de la corde vocale droite, s'étendant au fond du ventricule. Le résultat des biopsies pose le diagnostic de carcinome épidermoïde.

L'IRM montre une infiltration de la corde vocale droite avec extension au ventricule et au cartilage aryénoïde droite.

Des investigations complémentaires sont-elles nécessaires ?

Comment classe-t-on les carcinomes épidermoïdes du larynx ?

Quel(s) traitement(s) proposer ?

Quelles sont les conséquences d'une laryngectomie totale ?

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

- **Problème clinique** Dysphonie
- **Diagnostic** Paralyse laryngée unilatérale
Carcinome épidermoïde glottique
- **Entités nosologiques** Diagnostic et évaluation des dysphonies
Evaluation et prise en charge des paralysies laryngées
Cancers laryngés et leur traitement
Réhabilitation des laryngectomies
- **Aspect(s) privilégié(s)** Dysphonie
Cancers glottiques
Paralysies laryngées

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
- <i>L'anatomie du larynx</i>	ANATOMIE
- <i>Les fonctions du larynx</i>	PHYSIOLOGIE
- <i>Les méthodes d'évaluation des dysphonies</i>	ORL
- <i>Le diagnostic différentiel des dysphonies</i>	ORL
- <i>Les troubles de la motilité laryngée : Etiologies, investigations et traitements</i>	ORL
- <i>Les cancers laryngés : Investigations et traitements</i>	ORL
- <i>Les techniques pour assurer les voies aériennes</i>	ORL

PROBLEME

GLANDES SALIVAIRES

PROBLEME N°7: JE GONFLE SOUS LE MENTON

ENONCE INITIAL : ETAPE 1/2

Un patient de 70 ans consulte pour une tuméfaction apparue dans la région sous-maxillaire droite, depuis environ 10 jours. Au début, elle apparaissait après les repas et régressait en quelques minutes, mais depuis 2 jours, elle persiste et commence à faire mal.

Le patient est en bon état général, ne prend aucun médicament. Il ne fume pas, et ne boit qu'occasionnellement un verre de vin avec les repas.

A la palpation, la glande sous-maxillaire droite est agrandie, tendue, douloureuse. Médialement à la glande, on palpe une adénopathie de 2 cm dans son plus grand axe, douloureuse aussi. La muqueuse du plancher buccal droit est un peu rouge et on palpe une petite masse, dure, indolore, à 1 cm en arrière de la caroncule.

L'examen clinique révèle aussi une masse de 3 cm de diamètre centrée sur l'angle de la mandibule, débordant vers l'arrière jusqu'à la mastoïde. Le malade ne s'en est jamais inquiété puisqu'elle est présente depuis plusieurs années et n'occasionne aucune gêne !

- *Ce patient, souffre-t-il d'une ou deux affections ?*
Quel est le diagnostic différentiel pour les 2 affections ?

ENONCE : ETAPE 2/2

Vous revoyez le malade après la fin du traitement de l'affection aiguë dont il est maintenant guéri. Il est temps de discuter avec lui de l'autre problème.

- *Que lui dites-vous et quels arguments justifient vos propositions de traitement ?*

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

- **Problème clinique** - Tumeur parotidienne.
- **Diagnostic** - Adénome pléomorphe de la parotide.
- **Entités nosologiques** - Affections des glandes salivaires
– Paralysies faciales périphériques.
- **Aspect(s) privilégié(s)** - Adénome pléomorphe de la parotide.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
<i>Après avoir étudié ce problème, les étudiants devraient :</i>	
- Connaître les principales affections des glandes salivaires, oreillons, sialolithiases, parotidites marantiques, tumeurs bénignes et malignes, sialadénoses, syndromes de Sjögren et de Heerfordt.	ORL
- Connaître l'anatomie du nerf facial.	ORL
- Savoir différencier une paralysie faciale périphérique ou centrale.	ORL
- Connaître les causes de paralysie faciale, traumatiques, infectieuses, idiopathiques, tumorales.	ORL

PROBLEME

ORL GENERAL

PROBLEME N°8: J'AI MAL A LA GORGE

ENONCE INITIAL : ETAPE 1/3

Un patient de 40 ans présente depuis deux semaines des maux de gorge et une gêne à la déglutition. 5 jours après le début des symptômes, il a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement symptomatique.

Malgré une amélioration initiale, les douleurs ont repris, plus forte, principalement du côté droit. Il ne peut plus avaler. Parallèlement est apparu une tuméfaction cervicale du même côté.

Dans ses antécédents, il signale de fréquents épisodes de maux de gorge, qui durent de 2 à 3 jours, sans fièvre. Il ne fume pas et ne boit pas d'alcool.

- *Quelle était la conclusion du premier médecin et pourquoi n'a-t-il pas donné d'antibiotique : quel devait être son diagnostic différentiel et quel est le vôtre, sur la base de l'évolution ?*

ENONCE : ETAPE 2/3

A l'examen, l'ouverture buccale est limitée à 2 cm. A droite, il y a une voussure du pilier amygdalien antérieur. L'amygdale est à peine visible. A gauche, l'amygdale est normale. Au niveau du cou, on palpe une adénopathie jugulaire supérieure droite de 2,5 cm de diamètre, ovale, ferme, mobile et sensible.

- *Maintenant, quel est votre diagnostic différentiel, quel(s) examen(s) complémentaires demandez-vous éventuellement, et quel traitement proposez-vous ?*

ENONCE : ETAPE 3/3

Vous revoyez le patient un mois après l'épisode. Il va bien. L'ouverture buccale n'est plus limitée. Les amygdales sont petites, calmes. L'adénopathie cervicale a disparu.

Il demande s'il ne serait pas opportun de lui enlever les amygdales, pour éviter de nouveaux épisodes.

- *Que lui répondez-vous ?*

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

- **Problème clinique** - Maux de gorge.
- **Diagnostic** - Abscess péri-amygdalien.
- **Entités nosologiques** - Odynodysphagie persistante.
- **Aspect(s) privilégié(s)** - Complications d'une pharyngite

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
<i>Après avoir étudié ce problème, les étudiants devraient connaître :</i> - L'anatomie des 3 étages du pharynx et de l'anneau de Waldeyer. - Diverses formes de pharyngites (virales aiguës, angines bactériennes, mononucléose, Vincent, diphtérie, faux croup, scarlatine). - Le diagnostic différentiel d'une ulcération de l'amygdale (Vincent, cancer, syphilis). - Les complications des angines (abcès péri-amygdalien, rétro-pharyngé, septicémie). - Les indications à une tonsillectomie et ses complications.	ANATOMIE ORL ORL ORL ORL

PROBLEME

ORL PEDIATRIQUE

PROBLEME N°9: MON ENFANT N'ENTEND PAS BIEN

ENONCE INITIAL : ETAPE 1/3

Un enfant de 5 ans, consulte avec ses parents en raison d'une baisse de l'audition constatée depuis 1 mois. Il se plaint d'otalgie intermittente bilatérale, est souvent enrhumé. Il a déjà eu de nombreuses otites moyennes aiguës. Par ailleurs les parents trouvent que leur enfant parle mal pour son âge.

Quelle est la nature du problème actuel ?

Comment évaluer l'audition ?

Quels éléments dans l'anamnèse sont à rechercher ?

ENONCE : ETAPE 2/3

L'examen otologique au microscope montre un tympan mat des deux côtés. L'acoumétrie montre un weber centré, un rinné négatif des deux côtés et une voix chuchotée mal comprise des deux côtés. La rhinoscopie antérieure montre une rhinorrhée purulente active. L'examen du cavum montre une hypertrophie modérée des végétations avec un aspect inflammatoire. L'examen du larynx montre un discret érythème de la région rétro-crico-aryténoïdienne.

Quels diagnostics peut-on envisager à ce stade ?

Des investigations complémentaires sont-elles nécessaires ?

Quelle prise en charge proposez-vous ?

Quel est le degré d'urgence ? Pourquoi ?

ENONCE : ETAPE 3/3

Une prise en charge chirurgicale est décidée, l'enfant bénéficie d'une adénoïdectomie avec mise en place de drains trans-tympaniques. Il y avait du liquide séro-muqueux en abondance lors de la paracentèse.

Vous revoyez l'enfant 2 semaines après l'intervention. Les parents notent une amélioration évidente de l'audition et le nez est propre.

Des investigations complémentaires sont-elles nécessaires ?

Quelle est la suite de la prise en charge ?

CONTENU GENERAL DU PROBLEME

Problème clinique :	Hypoacousie chez l'enfant Otalgie IVRS à répétition
Diagnostic :	Otite séro-muqueuse bilatérale Retard du langage
Entités nosologiques :	Affections de l'oreille moyenne chez l'enfant IVRS à répétition
Aspect(s) privilégié(s) :	Bilan de l'audition chez l'enfant Prise en charge de l'hypoacousie chez l'enfant Diagnostics différentiels des hypoaccousies Facteurs de risque des IVRS à répétition

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	DISCIPLINES
- L'anatomie de l'oreille moyenne, de la cavité nasale et du pharynx :	ANATOMIE
- La fonction auditive :	PHYSIOLOGIE
- Les méthodes d'évaluation de l'audition chez l'enfant :	ORL
- Le diagnostic différentiel des hypoacousies :	ORL
- Les facteurs de risque des IVRS :	PÉDIATRIE/ORL
- Les facteurs de risque des OSM :	ORL
- Retard du langage :	PÉDIATRIE/ORL
Investigations et prise en charge	

COURS / SEMINAIRES

COURS D'ANATOMIE

Responsable : Prof. B. Stimec

Objectifs : Rappel des connaissances d'anatomie de la tête et du cou.

Les précisions complémentaires concernant ce cours vous seront communiquées lors de la séance d'accueil de votre AMC.

COURS DE RADIOLOGIE

Responsable : Prof. M. Becker

Objectifs d'apprentissage :

À la fin de cet AMC, l'étudiant devra :

- Connaître les indications courantes d'examens radiologiques en ORL
- Être en mesure d'expliquer le choix d'un examen radiologique en fonction de la présentation clinique
- Comprendre la sémilogie radiologique des pathologies présentées dans cet AMC (voir thèmes)
- Comprendre le diagnostic différentiel des principales entités telles que discutées lors de l'AMC.

Thèmes :

- Indications courantes d'examens radiologiques en ORL
- Infections de la sphère ORL : diagnostic différentiel et complications
- Traumatismes de la sphère ORL : os temporal, larynx/pharynx et corps étrangers
- Malformations congénitales de la sphère ORL : kyste latéro-cervical, kyste du tractus thyroïdienne, malformations de l'oreille interne
- Diverticule de Zenker
- Schwannome vestibulaire
- Sinusites aiguës et chroniques et polypose naso-sinusienne
- Oncologie ORL : tumeurs du pharynx et larynx, atteinte ganglionnaire
- Affections bénignes des glandes salivaires

Descriptif :

Cas pratiques avec leur présentation clinique et des séries d'images (radiographie standard, CT, ultrasons et IRM) illustrant les thèmes susmentionnés.